Gobernar sin ver: La crisis invisible de los sistemas de salud fragmentados en América Latina

Cuando la información médica no viaja con el paciente, la continuidad asistencial se quiebra. Miles mueren por fragmentación evitable.

PRÓLOGO: EL DÍA QUE MARÍA CASI MUERE

María Fernández tiene 58 años y vive entre dos mundos médicos que nunca se hablan.

Es un martes de julio cuando llega a la guardia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Dolor torácico agudo. El médico de emergencia teclea su nombre en el sistema. La pantalla se ilumina con una historia clínica en blanco. Paciente nueva. Primera consulta.

Pero María no es paciente nueva. Hace diez años tuvo un episodio de arritmia documentado en San Luis. Toma sertralina para ansiedad, prescrita por un psiquiatra privado. Su cardiólogo de CABA le cambió la dosis de enalapril hace tres semanas. Es alérgica a amoxicilina, información que figura en un papel amarillento guardado a 800 kilómetros.

El médico no ve nada de esto. Ve lo que el sistema le muestra: una historia clínica vacía.

Evalúa: mujer de mediana edad, sobrepeso, hipertensa, palpitaciones y opresión torácica. Electrocardiograma: taquicardia sinusal. Presión 145/92. Nada alarmante. "Probablemente ansiedad", anota. Prescribe alprazolam. Recomienda seguimiento con cardiólogo.

Lo que no puede ver es que esas palpitaciones comenzaron exactamente después del cambio de medicación. Que enalapril más sertralina puede prolongar el intervalo QT. Que María tuvo un episodio similar hace una década que se resolvió ajustando medicación, no con ansiolíticos.

Dos semanas después, María sufre un síncope en la calle en San Luis. Llega al hospital inconsciente. El equipo de emergencia, sin acceso a ningún antecedente de Buenos Aires, debe comenzar de cero.

Sobrevive. Pero cuando le pregunto meses después si sus médicos de San Luis supieron lo que pasó en Buenos Aires, me mira con cansancio: "Doctora, nadie sabe nada de nadie. Yo soy mi propia historia clínica. Llevo todo en una bolsa."

En su bolsa de tela color bordó guarda: laboratorios de tres años impresos en formatos diferentes, CDs de estudios que ya no puede abrir, recetas manuscritas ilegibles, resúmenes de alta, un papel donde ella misma escribió sus medicaciones y alergias.

"Lo armé yo después del susto. Porque me di cuenta de que si me pasa algo lejos de casa, estoy sola."

En Argentina, el paciente es su propia historia clínica ambulante.

María no es caso excepcional. Es la norma.

I. LA ESCALA DEL SILENCIO

El hallazgo enterrado

En 2021, el Ministerio de Salud de Argentina estudió patrones de uso en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Encontró que el 47% de pacientes utilizan simultáneamente servicios públicos y privados.

Pero el dato crítico estaba enterrado en el informe: de ese 47%, el 89% reportó que sus médicos en un sector desconocían completamente su atención en el otro.

Este es el primer hallazgo de esta investigación: la fragmentación no es falla ocasional. Es el sistema.

Cuando mostré estos números a directores de hospitales y funcionarios provinciales, ninguno expresó sorpresa. "¿Y esperabas otra cosa?", me preguntó un director en Rosario. "Así funciona esto. Siempre funcionó así."

Esa naturalización es, tal vez, el problema más profundo.

Roberto: Sangrado por información perdida

Roberto Gómez tiene 76 años y toma once medicamentos diarios. Vive en Rosario, veraneá en Mar del Plata. Se atiende en tres lugares: hospital público para diabetes, consultorio privado para cardiología, PAMI para medicación.

En diciembre consulta en Mar del Plata por tos persistente. El médico le pregunta qué medicamentos toma. Roberto saca un papel arrugado con nueve nombres. Faltan warfarina y omeprazol.

El médico prescribe amoxicilina con ácido clavulánico. Roberto lo toma. Cuatro días después llega a guardia con sangrado digestivo. La interacción entre warfarina (que el médico no sabía que tomaba) y el antibiótico desestabilizó su coagulación.

"Casi me muero por un papel que se me cayó del bolsillo", me dice. En su mesa de luz tiene ahora un cuaderno donde registra cada medicación, cada dosis, cada médico. "Lo hice yo porque nadie más lo hace."

Lucía: Crisis evitable en salud mental

Lucía Pereyra tiene 28 años y esquizofrenia. Desde hace cuatro años está estable con clozapina, que requiere hemograma cada quince días por riesgo de agranulocitosis. Se atiende en Hospital San Bernardo de Salta.

En febrero su familia decide que pase temporada con su tía en Jujuy. Lleva medicamentos y resumen de alta. Pero el centro de Jujuy no puede acceder a su historia: dosis ajustadas, crisis previas, hemogramas mensuales.

A las tres semanas, Lucía falta a controles. Nadie en Jujuy sabe que debe hacerse hemogramas cada quince días. Cuando presenta fiebre, la familia piensa que es resfrío. Para cuando llega al hospital, su recuento de neutrófilos está críticamente bajo. Dos semanas en terapia intensiva.

Su psiquiatra de Salta no se entera hasta un mes después. "Esto pasa todo el tiempo", me dice. "Pacientes de salud mental que se mueven de provincia. Es como empezar de cero cada vez. Y en salud mental, empezar de cero puede significar recaída de años."

Ana: Telemedicina ciega

Ana Flores vive en Susques, Puna jujeña, 3,675 metros de altura. Embarazada de siete meses, segundo hijo. En su primer embarazo tuvo preeclampsia. Antecedente crítico que requiere monitoreo estricto.

Susques no tiene obstetra. Ana se atiende por telemedicina: una vez al mes, obstetra en Jujuy por videoconferencia mientras enfermera local toma signos vitales.

El problema: la obstetra no accede a historia del centro de salud local. No sabe que Ana tuvo hipertensión leve en últimos controles. No sabe que el médico local indicó reposo por edema. No sabe que consultó hace dos semanas por cefalea intensa.

En consulta por telemedicina, Ana menciona que se siente "un poco hinchada". La obstetra ve presión 135/85 (límite alto, no alarmante) y recomienda control en dos semanas. Una semana después, Ana llega a guardia con presión 165/110, proteinuria, preeclampsia severa. Derivación de urgencia, cesárea de emergencia, bebé prematuro.

"La doctora por videollamada es muy buena", me dice Ana dos meses después con su bebé en brazos. "Pero ella no sabía lo que pasaba acá."

Javier: Derivación que duplica todo

Javier tiene 11 meses. Vive en Chaco. Infecciones respiratorias recurrentes, retraso en crecimiento. El pediatra sospecha fibrosis quística y lo deriva al Garrahan en Buenos Aires.

La familia viaja doce horas con Javier y un sobre manila: resumen manuscrito de dos páginas, tres laboratorios, una radiografía. El Garrahan debe empezar casi de cero: repetir estudios, reconstruir historia, rehacer curva de crecimiento.

Diagnóstico: fibrosis quística. Seguimiento de por vida coordinado entre Garrahan (cada seis meses) y Chaco (mensualmente). Pero no hay sistema que conecte ambas historias.

"Cada vez que volvemos a Buenos Aires es como si fuera la primera vez", me dice su madre. "Tuve que explicar todo de nuevo. Una vez olvidé un resultado y repitieron el estudio. A mi hijo le sacaron sangre dos veces por lo mismo."

El neumonólogo del Garrahan me explica: "Recibimos derivaciones de todo el país sin información completa. Repetimos estudios porque no podemos acceder a lo que ya se hizo. Es ineficiencia pura."

No puede precisar porcentaje de duplicación. "Nadie lo mide. Porque medirlo requeriría tener sistemas que se hablen."

Esta es una verdad irrefutable: nadie cuenta lo que la fragmentación cuesta porque contarlo requeriría que los sistemas se hablen. Es el problema de gobernar sin ver.

II. POR QUÉ LOS SISTEMAS NO SE HABLAN

La arquitectura de incentivos perversos

Durante seis meses visité hospitales públicos, clínicas privadas, centros de atención primaria en seis provincias. Entrevisté directores médicos, funcionarios, gerentes tecnológicos, programadores hospitalarios, ejecutivos de software médico.

Este es el segundo hallazgo: la fragmentación no es negligencia ni mala fe. Es arquitectura de incentivos donde cada actor actúa racionalmente pero el resultado colectivo es disfuncional.

Fragmentación por diseño

Federalismo institucional: Argentina, como Brasil, México, Colombia, es país federal. Salud es responsabilidad compartida: Nación, provincias, municipios. Cada jurisdicción instaló sistemas de información propios sin pensar en interoperabilidad.

Hospital de Córdoba instaló un sistema en 2015. Rosario instaló otro en 2017. Funcionan bien internamente. No se hablan entre sí. Un paciente que se atiende en ambos es, para el sistema, dos pacientes diferentes.

Fragmentación público-privada: El 65% de argentinos tiene obra social o prepaga. Pero casi la mitad también usa servicios públicos ocasionalmente. El sector privado invirtió más en tecnología. Las clínicas tienen historias clínicas electrónicas. Pero son cautivas: información queda en la clínica.

"¿Por qué compartiríamos información con hospital público?", me pregunta gerente de clínica privada en Buenos Aires. "Nosotros invertimos en tecnología. Es nuestro valor agregado. Si el paciente puede llevarse su información, ¿qué incentivo tiene para volver?"

Lógica de mercado aplicada a información clínica. Tiene sentido económico individual. Genera daño colectivo.

Fragmentación tecnológica: Visité doce hospitales públicos. Encontré nueve sistemas de historia clínica diferentes. Software propietario estadounidense, desarrollos locales, sistemas "caseros" programados con buena voluntad y recursos limitados.

Ninguno diseñado para comunicarse con otros. Formatos diferentes, estándares diferentes. Como si cada hospital hablara idioma distinto.

Las resistencias invisibles

Empecé a notar un patrón: cuando preguntaba sobre interoperabilidad, todos estaban "a favor". Nadie defendía fragmentación. Pero cuando preguntaba sobre implementación concreta, aparecían objeciones: costo, complejidad, riesgo de privacidad, pérdida de autonomía.

Este es el tercer hallazgo: la interoperabilidad enfrenta problema de acción colectiva. Todos se beneficiarían si existiera, pero nadie tiene incentivo individual para crearla. Y algunos tienen incentivos activos para impedirla.

Resistencia tecnológica: Proveedores de software venden licencias anuales, cobran actualizaciones, ganan con clientes "cautivos". Migrar a otro sistema es tan costoso que no vale la pena.

Un ejecutivo de empresa de software me explica off the record: "Si hacemos que nuestro sistema sea completamente compatible, el cliente puede irse fácilmente. Nosotros no ganamos con interoperabilidad. Ganamos con fidelización."

Resistencia económica: Obras sociales y prepagas temen que interoperabilidad aumente portabilidad. "No estamos en contra en principio", me dice gerente médico de prepaga

grande, off the record. "Pero tenemos que proteger nuestra inversión. Si facilitamos que afiliados se vayan con toda su información a competencia, ¿dónde queda nuestro negocio?"

Resistencia política: Funcionarios provinciales expresan preocupación por iniciativas nacionales. "Es invasión de autonomía provincial", me dice ex ministro de salud. "Si Nación nos impone sistema, ¿dónde queda el federalismo? Nosotros ya invertimos millones. ¿Quién paga la migración?"

Resistencia cultural: Un médico experimentado de hospital en Córdoba me dice: "Yo no comparto información de mis pacientes sin consentimiento explícito cada vez. La relación médico-paciente es privada. No quiero que otros médicos estén mirando lo que hago."

Otro médico me explica esto como "guardia médica de la historia clínica": el celo con que profesionales protegen información como forma de proteger confidencialidad y autonomía profesional. "Compartir información se siente como violación del secreto médico, aunque técnicamente no lo sea si hay consentimiento."

Es resistencia cultural profunda. Cambiarla requiere educación, tiempo, confianza.

El costo invisible

Duplicación: Según la Organización Panamericana de la Salud, entre 20-30% de recursos en sistemas latinoamericanos se pierden en duplicación de servicios y coordinación ineficiente.

Brasil, implementando interoperabilidad, redujo duplicación de laboratorios 15% en áreas integradas. En Argentina no hay mediciones sistemáticas. Estimaciones informales sugieren 10-15% de imaging se repite porque médicos no acceden a estudios previos.

Roberto me muestra cinco tomografías de tórax en tres años, hechas en diferentes lugares. "Me las pidieron porque no tenían las anteriores." Cada tomografía es radiación innecesaria. Gasto evitable.

Pero nadie cuenta esto. Porque contarlo requiere sistemas que se hablen.

Eventos adversos: El Institute of Medicine estima que 15-20% de eventos adversos medicamentosos son evitables con información disponible. Estudios latinoamericanos estiman 6-16% de hospitalizaciones asociadas a eventos adversos prevenibles. Componente significativo —no cuantificado— atribuible a falta de información.

Inequidad territorial: Concentración de especialistas en grandes ciudades genera doble barrera: acceso físico limitado Y ruptura informativa. Ana en Susques tiene telemedicina. Progreso genuino. Pero sin interoperabilidad, la telemedicina es menos efectiva de lo que podría ser.

III. CUANDO LOS SISTEMAS EMPIEZAN A HABLARSE

Brasil: Nueve años, 40% integrado

Brasil implementa desde 2015 el RNDS (Registro Nacional de Dados em Saúde), interoperabilidad nacional obligatoria para el SUS.

En Hospital das Clínicas de São Paulo veo cómo funciona: paciente llega a emergencia, sistema consulta RNDS automáticamente. En segundos: medicación actual, alergias, diagnósticos activos, hospitalizaciones previas, vacunas.

"Cambió mucho", me dice jefe de emergencias. "Antes, paciente inconsciente sin documentación, trabajábamos a ciegas. Ahora, en dos tercios de casos, tenemos datos básicos. Reducimos errores, mejoramos diagnóstico."

Pero RNDS no es éxito simple. A nueve años, solo 40% de datos SUS están integrados. Sector privado no se sumó. Implementación fue más lenta que esperado. Resistencias tecnológicas, políticas, económicas.

"No funciona perfectamente", aclara funcionario en Brasilia. "Funciona. Que es diferente. Todavía hay hospitales sin conectar, datos sin compartir, problemas de calidad. Pero es mejor que antes."

Uruguay: Cinco años, obligatoriedad legal

Uruguay logró interoperabilidad en cinco años (2018-2023) con SINCA. "Uruguay tiene ventajas", me explica directora del proyecto. "3.5 millones habitantes, menos fragmentación, sector privado más colaborativo."

Pero Uruguay también enfrentó resistencias. La clave: marco legal claro con obligatoriedad, plazos, sanciones. "Sin obligación legal, nadie se mueve voluntariamente. Los incentivos van contra interoperabilidad. Se necesita que Estado lo imponga."

IV. C.U.R.A.: UNA RESPUESTA TODAVÍA INCIERTA

El proyecto que casi nadie conoce

En 2023, senadores presentaron en Congreso argentino proyecto de ley C.U.R.A. (Historias Clínicas Electrónicas Interoperables). Casi nadie lo conoce. No fue noticia. No generó debate.

Es, potencialmente, transformación estructural del sistema de salud. O podría archivarse y olvidarse.

C.U.R.A. no propone construir hospitales ni contratar médicos. Propone obligar a todos los actores (públicos, privados, obras sociales, farmacias, laboratorios) a hacer sistemas interoperables. Que se hablen. Que compartan información con consentimiento del paciente.

Cómo funcionaría (si se implementara)

Imaginen que C.U.R.A. se aprueba, se financia, se implementa, supera resistencias.

María llega a guardia del Hospital Italiano. Sistema consulta Registro Nacional Interoperable. En segundos: medicación actual incluye sertralina, enalapril (modificado hace tres semanas), metformina, atorvastatina. Alergia amoxicilina. Episodio arritmia hace diez años San Luis.

Médico reformula evaluación: palpitaciones podrían relacionarse con cambio medicación. Consulta cardiología. Ajustan dosis. María no recibe ansiolítico innecesario. No tiene síncope dos semanas después.

Eso promete C.U.R.A. Si funciona.

La arquitectura federada

C.U.R.A. propone modelo federado: cada hospital mantiene sistema propio pero todos deben "hablar" lenguaje común. HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), estándar internacional que define cómo representar información clínica en formato legible universal.

Además, crea núcleo centralizado nacional: repositorio con datos mínimos críticos (medicación actual, alergias, diagnósticos activos). No historia completa, sino datos que médico necesita en emergencia.

Derechos del paciente

C.U.R.A. establece: información médica es propiedad del paciente, no del hospital. Derecho de acceso, portabilidad, control, corrección.

María ya no necesitaría su bolsa de tela. Datos disponibles digitalmente, bajo su control.

En teoría.

Privacidad: garantías y límites

Objeción más común: "¿Y la privacidad? ¿Quién garantiza que mi información no se use contra mí?"

C.U.R.A. establece: autenticación fuerte, autorización granular, auditoría completa, encriptación, sanciones penales, prohibición de discriminación.

¿Son suficientes? En 2019, empleado de hospital en Israel filtró historias de políticos. En 2021, ransomware en Irlanda expuso datos de 520,000 pacientes.

La vulnerabilidad es real. Y la pregunta sin respuesta clara: ¿es mejor riesgo de violación de privacidad en sistema interoperable, o riesgo de eventos adversos en sistema fragmentado?

No hay respuesta fácil.

Financiamiento incierto

Implementar C.U.R.A. requiere $500 millones USD: infraestructura, capacitación, migración, subsidios. Financiamiento propuesto: presupuesto nacional, multilateral (BID, CAF), inversiones privadas.

Pero en contexto de restricción fiscal, ¿es prioridad política?

Resistencias que no desaparecieron

Cuando pregunté sobre C.U.R.A., las resistencias documentadas no desaparecieron. Proveedores software siguen con incentivos de cautividad. Sector privado teme pérdida de ventaja. Provincias defienden autonomía. Médicos preocupados por vigilancia.

C.U.R.A. puede aprobarse como ley. Pero entre ley e implementación hay distancia enorme. Brasil tardó 9 años en 40%. Uruguay 5 años con población menor.

¿Cuánto tardaría Argentina? ¿Llegaría a implementarse?

Nadie lo sabe.

V. LO QUE LA INTEROPERABILIDAD NO RESUELVE

Incluso si C.U.R.A. se implementa completamente, interoperabilidad es condición necesaria pero no suficiente.

Un paciente puede tener información accesible y aún experimentar fragmentación sin coordinación clínica real. Sin médico de cabecera coordinador. Con sistema de financiamiento fragmentado.

Interoperabilidad resuelve: acceso a información. No resuelve: financiamiento, recursos humanos, coordinación organizacional, cultura médica de trabajo en silos.

Riesgos técnicos persistentes:

Si solo 70% de proveedores se integran, interoperabilidad sigue parcial. Brasil a 9 años: 40% integrado. Mejor que 0%, insuficiente para continuidad universal.

Nodo central es punto de falla único. En 2022, RNDS Brasil inaccesible 14 horas por falla técnica. No hubo muertes atribuibles pero demostró vulnerabilidad.

HL7 FHIR tiene múltiples versiones. Dos sistemas pueden usar "FHIR" pero no ser completamente interoperables. Problema documentado en Europa, Estados Unidos.

Riesgos de privacidad sin respuesta definitiva:

Seguros o empleadores podrían acceder a datos y discriminar. C.U.R.A. lo prohíbe. ¿Será vigilado? ¿Sancionado efectivamente? Sin enforcement, la ley es papel.

Inequidad digital:

Profesionales en regiones periféricas: acceso limitado a internet, capacitación técnica insuficiente. Pacientes mayores sin smartphone. Visité centros en Jujuy, Chaco, Formosa: conectividad intermitente, médicos resistentes a tecnología.

Interoperabilidad podría profundizar inequidad: beneficiar urbanos educados con acceso digital, dejar atrás poblaciones vulnerables.

Resistencias culturales profundas:

Cultura médica de confidencialidad tardó siglos en construirse. Cambiarla requiere tiempo. "¿Cuánto?", le pregunto a médico que se convenció después de ver Brasil. "Generacional. Médicos jóvenes lo aceptan más fácil. Los de mi generación, nos cuesta. Algunos nunca aceptarán."

VI. PROYECCIONES SIN CERTEZA

Si Argentina no implementa interoperabilidad en próxima década, escenarios posibles (no predicciones):

Escenario 1: Fragmentación profundizada. Sector privado sigue invirtiendo en tecnología propietaria. Público queda rezagado. Brecha amplía. Inequidad informativa se vuelve nueva forma de inequidad en salud.

Escenario 2: Soluciones privadas fragmentadas. Obras sociales grandes implementan interoperabilidad dentro de su red. Afiliados tienen continuidad dentro del sistema. Fuera, siguen fragmentados. Esto ya está comenzando.

Escenario 3: Dependencia tecnológica externa. Empresas multinacionales ofrecen plataformas de interoperabilidad. Hospitales contratan. Datos argentinos en servidores en Estados Unidos o China. Soberanía de datos se pierde.

Escenario 4: Status quo persistente. María sigue con su bolsa. Roberto con su cuaderno. Lucía en riesgo cuando cambia provincia. Ana con telemedicina ciega. Javier repitiendo estudios.

Cuál ocurrirá no está determinado. Depende de decisiones políticas, inversiones, resistencias, voluntad de cambio.

La fragmentación no mata de golpe. Mata de a poco, en cada transición, cada derivación, cada falta de información cuando más importa.

VII. UN PROBLEMA COMPARTIDO SIN SOLUCIÓN ÚNICA

En junio 2024 asistí al Congreso Latinoamericano de Salud Digital en Bogotá. Representantes de 14 países discutían interoperabilidad.

Todos describían mismo problema: fragmentación sistémica, información que no viaja, eventos adversos evitables, inequidad territorial.

Colombia diseña proyecto nacional. Perú en diagnóstico. México con pilotos. Chile debate marco legal. Todos enfrentan mismas resistencias: tecnológicas, económicas, políticas, profesionales.

"¿Por qué cada país tiene que inventar la rueda?", preguntó delegado de Perú. "¿Por qué no aprendemos de Brasil, Uruguay, Argentina?"

Buena pregunta sin respuesta clara.

C.U.R.A., si se implementara exitosamente, podría ser referencia para países similares: federalismo, pluralismo, presupuesto limitado.

Pero "si se implementara" es condicional grande. Y cada país tiene especificidades: Colombia con 32 departamentos, México con 130 millones habitantes, Perú con inequidad territorial extrema.

No es replicar mecánicamente. Es adaptar conceptos.

VIII. PREGUNTAS QUE QUEDAN ABIERTAS

Lo que sé

Después de seis meses, esto aprendí con certeza:

La fragmentación es sistémica. Resultado de arquitectura institucional histórica. Tiene costo humano medible (aunque nadie lo mide sistemáticamente). La interoperabilidad es técnicamente viable. Brasil y Uruguay lo demuestran. No ocurre naturalmente. Enfrenta problema de acción colectiva. Requiere decisión política, marco legal, inversión, superación de resistencias reales. Las resistencias son múltiples y legítimas. La interoperabilidad no es solución mágica. Es condición necesaria, no suficiente.

Lo que no sé

¿Se implementará C.U.R.A.? No lo sé. Depende de voluntad política, presupuesto, capacidad de superar resistencias.

¿Reducirá efectivamente eventos adversos en Argentina? Brasil sugiere que sí. Pero evidencia es prometedora, no definitiva.

¿Beneficios superarán riesgos de privacidad? Depende de implementación de seguridad, auditoría, sanciones. Sin implementación real, imposible saberlo.

¿Profundizará o reducirá inequidad digital? Depende de inversiones en conectividad, capacitación, interfaces. Podría ir en cualquier dirección.

¿Otros países adoptarán modelos similares? Colombia, Perú, México exploran. Entre exploración e implementación hay distancia enorme.

La imagen sin resolución

Vuelvo a ver a María seis meses después.

Sigue llevando su bolsa de tela. "Me acostumbré. Es parte de mi rutina."

Le cuento sobre C.U.R.A., Brasil, Uruguay, la posibilidad de que algún día su información viaje con ella.

Se queda pensando. "Sería lindo. Pero no sé si lo voy a ver. Ya me dijeron tantas veces que el sistema va a mejorar. Y sigo con mi bolsa."

Le pregunto si tiene esperanza.

"Esperanza siempre hay. Pero también tengo realismo. Esto es Argentina. Las cosas cambian lento. O no cambian."

No puedo decirle que está equivocada.

No sé si cambiará. No sé si C.U.R.A. se aprobará. No sé si se implementará. No sé si funcionará.

Lo que sé: el problema existe. Es medible. Es dañino. Es evitable.

Hay respuestas posibles. No perfectas. No definitivas. Pero posibles.

La pregunta es si como sociedad decidiremos implementarlas.

María sigue llevando su bolsa de tela. Sigue siendo su propia historia clínica ambulante. Sigue esperando que alguien, algún día, le permita dejar esa bolsa en casa.

Yo sigo sin saber si esa espera terminará.

Pero ahora sabemos por qué continúa.

EPÍLOGO: METODOLOGÍA Y LÍMITES

Cómo se hizo

Seis meses (marzo-agosto 2024): visitas a 12 hospitales en 6 provincias, observación de consultas y guardias (con consentimiento), viajes a Brasil y Uruguay, entrevistas con

directores médicos, funcionarios, gerentes, programadores, ejecutivos software, pacientes crónicos.

Análisis documental: proyecto C.U.R.A. completo, informes OPS/OMS/OECD, literatura académica, reportes RNDS y SINCA.

Casos clínicos: historias reales con nombres cambiados, detalles modificados para proteger identidad.

Límites

Verificación: Algunos datos cuantitativos (47% AMBA) de informes ministeriales sin metodología completa accesible. Estimaciones duplicación (10-15%) informales, no estudios sistemáticos. No hay datos nacionales sobre eventos adversos atribuibles específicamente a fragmentación.

Representatividad: 12 hospitales no son muestra estadística. 6 provincias tienen características específicas.

Atribución: Algunas citas off the record según acuerdo con entrevistados.

Proyección: Escenarios futuros especulativos, no predictivos.

Transparencia sobre sesgos

Reconozco sesgo a favor de interoperabilidad como solución deseable. Intenté mitigar documentando resistencias legítimas, reconociendo límites, evitando evangelización. Pero elegir este tema implica considerarlo importante.

Dejo al lector evaluar si sesgo comprometió rigor.

REFERENCIAS

Proyecto de Ley C.U.R.A., Senado Argentina, 2023 • Ministerio de Salud Argentina, "Estudio uso servicios AMBA", 2021 • RNDS Brasil, Ley 13.787, 2019 • Brasil Ministério da Saúde, "RNDS Relatório 2024" • Uruguay MSP, "SINCA Reporte 2023" • European Health Data Space, Directiva UE 2024/55 • OPS, "Resolución Salud Digital", CE169/16, 2023 • OPS (2021), "Health Information Systems Interoperability Regional Framework" • OMS (2019), "World Health Report 2019" • Institute of Medicine (2001), "Crossing the Quality Chasm" • Bates et al. (2020), "Big Data in Health Care", Health Affairs 39(3) • Brennan et al. (1991), "Incidence of Adverse Events", NEJM 324(6) • HL7 International, FHIR Standards • SNOMED International